

Приказ Министерства здравоохранения РФ

от 6 июня 2013 г. N 354н

«О порядке проведения патологоанатомических вскрытий»

В соответствии со [статьями 14, 67](#) Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446), приказываю:

1. Утвердить:

порядок проведения патолого-анатомических вскрытий согласно [приложению N 1](#);

форму учетной медицинской документации N 013/у "Протокол патолого-анатомического вскрытия" согласно [приложению N 2](#);

форму учетной медицинской документации N 013-1/у "Протокол патолого-анатомического вскрытия плода, мертворожденного или новорожденного" согласно [приложению N 3](#);

форму учетной медицинской документации N 015/у "Журнал регистрации поступления и выдачи тел умерших" согласно [приложению N 4](#).

2. Признать утратившим силу [приказ](#) Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации от 29 апреля 1994 г. N 82 "О порядке проведения патолого-анатомических вскрытий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июня 1994 г., регистрационный N 588).

Министр

В.И. Скворцова

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 декабря 2013 г.

Регистрационный N 30612

Приложение N 1
к [приказу](#) Министерства здравоохранения РФ
от 6 июня 2013 г. N 354н

Порядок **проведения патолого-анатомических вскрытий**

1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения патолого-анатомических вскрытий в патолого-анатомических бюро или патолого-анатомических отделениях медицинских организаций, имеющих лицензии на осуществление медицинской деятельности, предусматривающие выполнение работ (услуг) по патологической анатомии (далее - патолого-анатомические бюро (отделения)).

Действие настоящего Порядка не распространяется на отношения, связанные с проведением судебно-медицинской экспертизы трупа, донорством органов и тканей человека и их трансплантацией (пересадкой), а также с передачей невостребованного тела, органов и тканей умершего человека для использования в медицинских, научных и учебных целях.

2. Патолого-анатомическое вскрытие проводится врачом-патологоанатомом в целях получения данных о причине смерти человека и диагнозе заболевания. Патолого-анатомическое вскрытие осуществляется путем посмертного патолого-анатомического исследования внутренних органов и тканей умершего человека, новорожденных, а также мертворожденных и плодов.

3. По религиозным мотивам при наличии письменного заявления супруга или близкого родственника (детей, родителей, усыновленных, усыновителей, родных братьев и родных сестер, внуков, дедушки, бабушки), а при их отсутствии иных родственников либо законного представителя умершего или при волеизъявлении самого умершего, сделанном им при жизни, патолого-анатомическое вскрытие не производится, за исключением случаев:

1) подозрения на насильственную смерть;

2) невозможности установления заключительного клинического диагноза заболевания, приведшего к смерти, и (или) непосредственной причины смерти;

3) оказания умершему пациенту медицинской организацией медицинской помощи в стационарных условиях менее одних суток;

4) подозрения на передозировку или непереносимость лекарственных препаратов или диагностических препаратов;

5) смерти:

а) связанной с проведением профилактических, диагностических, инструментальных, анестезиологических, реанимационных, лечебных мероприятий, во время или после операции переливания крови и (или) ее компонентов;

б) от инфекционного заболевания или при подозрении на него;

в) от онкологического заболевания при отсутствии гистологической верификации опухоли;

г) от заболевания, связанного с последствиями экологической катастрофы;

д) беременных, рожениц, родильниц (включая последний день послеродового периода) и детей в возрасте до двадцати восьми дней жизни включительно;

6) рождения мертвого ребенка;

7) необходимости судебно-медицинского исследования*(1).

4. Направление тел умерших, а также мертворожденных, на патолого-анатомическое вскрытие, если отсутствуют обстоятельства, препятствующие проведению патолого-анатомического вскрытия (абзац первый пункта 3 настоящего Порядка), осуществляется после констатации биологической смерти человека медицинским работником медицинской организации или выездной бригады скорой медицинской помощи в порядке, установленном [Правилами](#) определения момента смерти человека, в том числе критериями и процедурой установления смерти человека, утвержденными [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2012 г. N 950 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 39, ст. 5289).

5. Направление на патолого-анатомическое вскрытие тел умерших в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, организует заведующий отделением медицинской организации, в котором находился пациент на момент наступления смерти, а в случае его отсутствия - дежурный врач.

6. В случае наступления смерти вне медицинской организации направление на патолого-анатомическое вскрытие тел умерших организует врач (фельдшер) медицинской организации, в которой умерший получал первичную медико-санитарную помощь, либо медицинской организации, осуществляющей медицинское обслуживание территории, где констатирована смерть.

7. В случае наступления смерти в стационарных учреждениях социального обслуживания, образовательных организациях, в которых созданы условия для проживания обучающихся, и домах ребенка направление на патолого-анатомическое вскрытие тел умерших организует врач (фельдшер) указанных организаций либо медицинской организации, осуществляющей медицинское обслуживание этих организаций.

8. Медицинский работник в случаях, предусмотренных [пунктами 5-7](#) настоящего Порядка, оформляет и подписывает направление на патолого-анатомическое вскрытие в патолого-анатомическое бюро (отделение), в котором указываются следующие сведения:

1) наименование организации, врач (фельдшер) которой осуществляет направление тела умершего в патолого-анатомическое бюро (отделение);

2) фамилия, имя, отчество и дата рождения умершего (фамилия матери плода и дата отделения плода);

3) дата и время наступления смерти (мертворождения).

9. Для проведения патолого-анатомического вскрытия вместе с телом умершего (мертворожденного, плода) в патолого-анатомическое бюро (отделение) направляется медицинская документация умершего (мертворожденного, плода) - медицинская карта стационарного больного (медицинская карта родов, медицинская карта новорожденного, история развития ребенка, медицинская карта амбулаторного больного), содержащая результаты проведенных лабораторных и инструментальных диагностических исследований, карты анестезиологических и реанимационных пособий, протоколы оперативных вмешательств, заключительный клинический диагноз с указанием кода диагноза в соответствии с [МКБ-Х*\(2\)](#) и посмертный эпикриз.

10. Патолого-анатомические бюро (отделения), в которые осуществляется доставка тел умерших, определены органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья на основании установленных законодательством Российской Федерации в сфере охраны здоровья полномочиями*(3).

11. При подозрении на наличие признаков особо опасных инфекционных болезней у

умершего, мертворожденного или плода патолого-анатомическое вскрытие осуществляется в изолированных помещениях патолого-анатомического бюро (отделения), предназначенных для вскрытия таких трупов, в соответствии с требованиями государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.

В случае если при проведении патолого-анатомического вскрытия обнаружены признаки инфекционных болезней, информация об этом направляется медицинской организацией, в которой проводилось патолого-анатомическое вскрытие, в территориальный орган, уполномоченный осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор по месту регистрации заболевания умершего, мертворожденного или плода в соответствии с порядками оказания медицинской помощи при инфекционных заболеваниях, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации*(4).

12. При подозрении на наличие признаков насильственной смерти, признаков потребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача тело умершего направляется на судебно-медицинскую экспертизу в соответствии с порядком проведения судебно-медицинских экспертиз, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии с [частью 2 статьи 62](#) Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

13. Патолого-анатомические вскрытия подразделяются на следующие категории сложности:

1) патолого-анатомическое вскрытие первой категории сложности - патолого-анатомическое вскрытие (макроскопическое исследование) без проведения гистологического исследования;

2) патолого-анатомическое вскрытие второй категории сложности - патолого-анатомическое вскрытие плода, мертворожденного или умершего новорожденного, а также патолого-анатомическое вскрытие при установленном клиническом диагнозе, включая осложнения основного заболевания, при отсутствии неопределенности в трактовке механизмов и причины смерти (в том числе при ишемической болезни сердца, ревматических поражениях клапанов сердца вне обострения, инфаркте головного мозга, новообразованиях, подтвержденных гистологически, циррозе печени, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, аппендиците, холецистите, желчнокаменной болезни, аневризме аорты);

3) патолого-анатомическое вскрытие третьей категории сложности - патолого-анатомическое вскрытие при установленном клиническом диагнозе, включая осложнения основного заболевания, а также в случаях смерти после оперативных вмешательств (за исключением случаев, предусмотренных [подпунктами 4 и 5](#) настоящего пункта), когда возникают трудности в трактовке сущности патологического процесса, механизмов и причины смерти, что требует применения дополнительных гистологических и гистохимических окрасок, бактериоскопического, бактериологического, биохимического и других исследований (в том числе при кардиомиопатиях, перикардитах, миокардитах, эндокардитах, цереброваскулярных заболеваниях, сосудистой недостаточности кишечника, кишечной непроходимости, вирусных гепатитах, пиелонефритах, мочекаменной болезни, обструктивных болезнях легкого, сосудистой недостаточности конечностей, психических и нервных болезнях, алкоголизме, панкреатитах, амилоидозе);

4) патолого-анатомическое вскрытие четвертой категории сложности - патолого-анатомическое вскрытие при комбинированном основном заболевании или полипатии, при наличии дефектов диагностики и лечения, что вызвало трудности в трактовке характера патологического процесса, механизмов и причины смерти (в том числе при интраоперационной или ранней послеоперационной смерти, инфекционных заболеваниях (кроме ВИЧ-инфекции, особо опасных инфекций), заболеваниях беременных, рожениц и родильниц, при гнойно-воспалительных осложнениях, не диагностированных при жизни, сепсисе, болезнях крови и кроветворных органов, ревматических болезнях, заболеваниях спинного мозга, болезнях кожи и костно-мышечной системы, профессиональных заболеваниях, в том числе пневмокониозах, интерстициальных болезнях легких, болезнях эндокринной системы, болезнях накопления);

5) патолого-анатомическое вскрытие пятой категории сложности - патолого-анатомическое вскрытие при неустановленном клиническом диагнозе основного заболевания, когда имеются трудности в трактовке характера патологического процесса и причины смерти или необходимо применение дополнительных иммуногистохимических, молекулярно-биологических, электронно-микроскопических методов исследования (в том числе при новообразованиях неустановленного гистогенеза, особо опасных инфекционных болезнях, ВИЧ-инфекции).

14. Патолого-анатомическое вскрытие проводится в срок до трех суток после констатации

биологической смерти человека.

15. Сведения о поступлении в патолого-анатомическое бюро (отделение) тела умершего вносятся в форму учетной медицинской документации N 015/у "Журнал регистрации поступления и выдачи тел умерших" ([приложение N 4](#) к настоящему приказу) (далее - Журнал регистрации поступления и выдачи тел умерших).

16. При проведении патолого-анатомического вскрытия гистологический, биохимический, микробиологический и другие необходимые методы исследований отдельных органов, тканей умершего или их частей являются неотъемлемой частью диагностического процесса в целях выявления причин смерти человека, осложнений основного заболевания и сопутствующего заболевания, его состояния. Волеизъявление умершего, высказанное при его жизни, либо письменное заявление супруга, близкого родственника (детей, родителей, усыновленных, усыновителей, родных братьев и родных сестер, внуков, дедушки, бабушки), а при их отсутствии иных родственников либо законного представителя умершего о проведении таких исследований не требуется*(5).

17. Перед началом проведения патолого-анатомического вскрытия врач-патологоанатом изучает медицинскую документацию, представленную для проведения патолого-анатомического вскрытия, и, при необходимости, получает разъяснения у врачей-специалистов, принимавших участие в обследовании и лечении пациента.

18. На проведение патолого-анатомического вскрытия пациента, умершего в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, приглашается его лечащий врач (врач-акушер-гинеколог, врач-неонатолог), фельдшер, акушерка или заведующий отделением медицинской организации, в котором находился пациент на момент наступления смерти.

19. Этапы проведения патолого-анатомического вскрытия:

- 1) наружный осмотр тела;
- 2) вскрытие и исследование полостей тела;
- 3) извлечение органокомплекса;
- 4) изучение органов и тканей;
- 5) взятие биологического материала для гистологического и других дополнительных исследований;
- 6) приведение тела в достойный вид;
- 7) лабораторная обработка биологического материала;
- 8) микроскопическое изучение биологического материала.

20. Наружный осмотр тела включает в себя осмотр состояния кожных покровов, в том числе на наличие послеоперационных рубцов и ран, повязок, дренажей, патологических образований.

21. Вскрытие и исследование полостей тела включает в себя осмотр состояния стенок и содержимого полостей, топографического расположения органов, характеристику их серозного покрова.

22. Извлечение органокомплекса осуществляется с использованием методических приемов, позволяющих сохранить взаиморасположение внутренних органов и тканей.

23. Изучение органов и тканей производится в следующей последовательности:

- 1) головной мозг и оболочки мозга;
- 2) череп и придаточные пазухи;
- 3) язык, глотка, пищевод;
- 4) трахея, бронхи, легкое;
- 5) сердце и крупные сосуды;
- 6) средостение, забрюшинная клетчатка, грудная и брюшная полости;
- 7) грудная аорта, брюшная аорта, крупные артерии (почечные, брыжеечные, подвздошные);
- 8) почки, надпочечники, мочеточники;
- 9) поджелудочная железа, печень, желчный пузырь;
- 10) желудок, двенадцатиперстная кишка, тонкая кишка, толстая кишка;
- 11) мочевого пузырь, предстательная железа (матка, яичники);
- 12) магистральные сосуды конечностей;
- 13) кости и мягкие ткани;
- 14) плацента (при наличии);
- 15) плодные оболочки и пуповина (при наличии).

24. Взятие биологического материала для гистологического исследования (при наличии

медицинских показаний - гистохимического, иммуногистохимического, генетического, молекулярно-биологического исследований) включает в себя иссечение кусочков органов и тканей и помещение их в фиксирующие растворы. Гистологические, гистохимические, иммуногистохимические, генетические, молекулярно-биологические исследования выполняются в патолого-анатомическом бюро (отделении).

При наличии медицинских показаний производится взятие биологического материала для микробиологического (бактериологического, вирусологического), биохимического и (или) других необходимых исследований. Для проведения указанных исследований биологический материал передается в соответствующее структурное подразделение медицинской организации в нефиксированном (нативном) виде. Для микробиологического (бактериологического и вирусологического) исследования биологический материал забирается с соблюдением требований стерильности.

25. Патолого-анатомическое вскрытие проводится с соблюдением достойного отношения к телу умершего и сохранением максимально его анатомической формы.

После проведения патолого-анатомического вскрытия приведение тела в достойный вид осуществляется путем ушивания секционных разрезов и омывания водой.

26. Лабораторная обработка биологического материала, взятого для гистологического, иммуногистохимического, генетического, молекулярно-биологического исследований, включает в себя:

- 1) окончательную фиксацию;
- 2) проводку (обезвоживание и пропитывание парафином);
- 3) заливку в парафин с изготовлением парафиновых блоков;
- 4) микротомии (изготовление парафиновых срезов, монтирование их на предметные стекла и высушивание);
- 5) окраску, заключение и высушивание микропрепаратов;
- 6) сортировку микропрепаратов.

27. Микроскопическое изучение биологического материала представляет собой микроскопическое исследование микропрепаратов с помощью гистологических, гистохимических, иммуногистохимических методов исследований, а также сопоставление их результатов с данными макроскопического исследования.

28. По окончании этапов проведения патолого-анатомического вскрытия, предусмотренных [подпунктами 1-5 пункта 19](#) настоящего Порядка, в день проведения патолого-анатомического вскрытия врач-патологоанатом оформляет форму учетной медицинской документации N 013/у "Протокол патолого-анатомического вскрытия" или форму учетной медицинской документации N 013/у-1 "Протокол патолого-анатомического вскрытия плода, мертворожденного или новорожденного" ([приложения N 2-3](#) к настоящему приказу) (далее - протокол патолого-анатомического вскрытия).

29. Для выявления расхождения заключительного клинического диагноза и патолого-анатомического диагноза, а также дефектов оказания медицинской помощи производится сопоставление заключительного клинического диагноза и патолого-анатомического диагноза в части установленных: основного заболевания, осложнений основного заболевания, сопутствующих заболеваний.

Сведения о расхождении заключительного клинического диагноза и патолого-анатомического диагноза, а также о выявленных дефектах оказания медицинской помощи вносятся врачом-патологоанатомом в протокол патолого-анатомического вскрытия и направляются в медицинскую организацию, врач (фельдшер) которой выдал направление на патолого-анатомическое вскрытие.

30. Не позднее тридцати суток после завершения проведения патолого-анатомического вскрытия врач-патологоанатом осуществляет окончательное оформление протокола патолого-анатомического вскрытия, а также вносит в медицинскую карту стационарного больного (медицинскую карту родов, медицинскую карту новорожденного, историю развития ребенка медицинскую карту амбулаторного пациента) патолого-анатомический диагноз и клинико-патолого-анатомический эпикриз.

Копия протокола патолого-анатомического вскрытия вносится в медицинскую документацию умершего - медицинскую карту стационарного больного (медицинскую карту родов, медицинскую карту новорожденного, историю развития ребенка, медицинскую карту амбулаторного пациента), которая возвращается в медицинскую организацию.

31. Заключение о причине смерти и диагнозе заболевания по результатам патолого-анатомического вскрытия отражается в учетной [форме N 106/у-08](#) "Медицинское свидетельство о смерти" или в учетной [форме N 106-2/у-08](#) "Медицинское свидетельство о перинатальной смерти", которые утверждены [приказом](#) Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 декабря 2008 г. N 782н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2008 г., регистрационный N 13055), с изменениями, внесенными [приказом](#) Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. N 1687н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2012 г., регистрационный N 23490).

32. Заключение о причине смерти и диагнозе заболевания выдается супругу, близкому родственнику (детям, родителям, усыновленным, усыновителям, родным братьям и родным сестрам, внукам, дедушкам, бабушкам), а при их отсутствии иным родственникам либо законному представителю умершего, правоохранительным органам, органу, осуществляющему государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности, и органу, осуществляющему контроль качества и условий предоставления медицинской помощи, по их требованию*(6).

В случае, указанном в [абзаце 1](#) настоящего пункта, заключение о причине смерти и диагнозе заболевания оформляется выпиской из протокола патолого-анатомического вскрытия.

33. После завершения патолого-анатомического вскрытия тело умершего выдается для погребения супругу, близким родственникам (детям, родителям, усыновленным, усыновителям, родным братьям и родным сестрам, внукам, дедушкам, бабушкам), иным родственникам либо законному представителю умершего, а при отсутствии таковых - иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего.

Сведения о выдаче тела умершего вносятся в [Журнал](#) регистрации поступления и выдачи тел умерших.

34. В медицинской организации, проводящей патолого-анатомическое вскрытие, формируется архив, который включает следующие материалы, полученные по результатам патолого-анатомических вскрытий:

- 1) биологические материалы;
- 2) гистологические препараты;
- 3) протоколы патолого-анатомических вскрытий.

35. Биологические материалы, полученные при проведении патолого-анатомических вскрытий, хранятся в 10% растворе нейтрального формалина в архиве патолого-анатомического бюро (отделения) до окончания гистологического исследования и установления патолого-анатомического диагноза.

Гистологические препараты и биологические материалы в парафиновых блоках хранятся в архиве патолого-анатомического бюро (отделения) в течение трех лет.

Протокол патолого-анатомического вскрытия хранится в архиве медицинской организации, в которой проводится патолого-анатомическое вскрытие, в течение срока хранения медицинской карты стационарного больного (медицинской карты родов, медицинской карты новорожденного, истории развития ребенка, медицинской карты амбулаторного больного).

36. В случае выдачи по письменному запросу органов дознания, следствия, суда гистологических препаратов, биологических материалов в парафиновых блоках и копий протоколов патолого-анатомического вскрытия сведения об этом фиксируются записью в журнале, которая должна содержать:

- 1) дату выдачи гистологических препаратов, биологических материалов в парафиновых блоках и копий протоколов патолого-анатомического вскрытия;
- 2) сведения об умершем, указанные в [подпункте 2 пункта 8](#) настоящего Порядка;
- 3) реквизиты письменного запроса органов дознания, следствия, суда;
- 4) сведения о лице, которому выданы гистологические препараты, биологические материалы в парафиновых блоках и копии протоколов патолого-анатомического вскрытия, и его подпись;
- 5) сведения о работнике, который произвел выдачу гистологических препаратов, биологических материалов в парафиновых блоках и копий протоколов патолого-анатомического вскрытия и его подпись;
- 6) отметка о возвращении гистологических препаратов, биологических материалов в парафиновых блоках.

37. Медицинские отходы, образовавшиеся в результате проведения

патолого-анатомического вскрытия, включая гистологические препараты и биологические материалы в парафиновых блоках, по истечении срока, предусмотренного [пунктом 35](#) настоящего Порядка, утилизируются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами [СанПиН 2.1.7.2790-10](#) "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами", утвержденными [постановлением](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 9 декабря 2010 г. N 163 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 17 февраля 2011 г., регистрационный N 19871).

*(1) В соответствии с [частью 3 статьи 67](#) Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

*(2) [Международная статистическая классификация](#) болезней и проблем, связанных со здоровьем (X пересмотр).

*(3) [Статья 16](#) Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

*(4) [Приказ](#) Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2012 г. N 521н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям с инфекционными заболеваниями" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 июля 2012 г., регистрационный N 24867); [приказ](#) Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 января 2012 г. N 69н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослым больным при инфекционных заболеваниях" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 апреля 2012 г., регистрационный N 23726).

*(5) В соответствии с [частью 4 статьи 67](#) Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

*(6) В соответствии с [частью 5 статьи 67](#) Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

* Медицинская карта стационарного пациента, медицинская карта амбулаторного пациента, медицинская карта родов, медицинская карта новорожденного.

Приложение N 2
к приказу Министерства здравоохранения РФ
от 6 июня 2013 г. N 354н

(полное наименование медицинской организации)

Код формы по ОКУД _____
Код учреждения по ОКПО _____

Медицинская документация
Учетная форма N 013/у

(адрес медицинской организации)

Утверждена приказом Минздрава России
от 6 июня 2013 г. N 354н

ПРОТОКОЛ
патолого-анатомического вскрытия N _____

" ____ " _____ 20 ____ г.

1. Наименование медицинской организации и отделения, в котором наблюдался и умер пациент(ка) _____
2. Медицинская карта амбулаторного (стационарного) пациента N _____
3. Фамилия, имя, отчество умершего(ей) _____
4. Пол: мужской 1, женский 2 _____
5. Дата рождения: число _____ месяц _____ год _____
6. Дата смерти: число _____ месяц _____ год _____, время _____
7. Место жительства (регистрации) умершего(ей): республика, край, область _____
район _____ город _____ населенный пункт _____
улица _____ дом _____ квартира _____
8. Местность: городская - 1, сельская - 2 _____
9. Семейное положение: состоял(а) в зарегистрированном браке - 1, не состоял(а) в зарегистрированном браке - 2, неизвестно - 3 _____
10. Образование: профессиональное: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее - 3, начальное - 4; общее: среднее (полное) - 5, основное - 6, начальное - 7; не имеет начального образования - 8, неизвестно - 9 _____

Основное заболевание: _____

Осложнения основного заболевания: _____

Сопутствующие заболевания: _____

ПАТОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКОЕ ВСКРЫТИЕ

19. Наружный осмотр тела:

рост _____ см., масса тела _____ кг.,

телосложение _____,

состояние питания _____,

состояние мышечной и костной систем _____,

кожный покров: головы _____,

шеи _____, груди _____,

туловища _____, конечностей _____;

трупные пятна и их расположение _____,

выраженность и распространенность трупного окоченения _____,

состояние естественных отверстий _____,

наружные половые органы _____,

операционные раны: длина разреза _____ см., характер операционной раны _____,

швы _____, выделения из раны _____,

следы инъекций и изменения в их зоне _____.

20. Брюшная полость:

расположение органов _____,

листки брюшины _____, сращения _____,

наличие свободной жидкости в брюшной полости _____ ;
внешний вид и размеры внутренних органов до вскрытия: диафрагма _____ ,
печень _____ , селезенка _____ ,
большой сальник _____ , желудок _____ ,
кишечник _____ , мочевого пузырь _____ ,
червеобразный отросток _____ .

21. Грудная полость:

расположение органов _____ ,
объем легкого _____ , сращения и жидкость в плевральных полостях _____ ;
наружный осмотр сердца: форма _____ , расположение _____ ;
вилочковая железа: расположение _____ , величина _____ .

22. Полость черепа:

мягкие покровы головы при отделении их от черепа _____ ,
кости черепа _____ ;
оболочки головного мозга: мягкая _____ ,
паутинная _____ , твердая _____ ;
кровенаполнение сосудов _____ ;
головной мозг: объем _____ , масса _____ ,
консистенция _____ , вещество мозга _____ ,
желудочки _____ , мозжечок _____ ,
продолговатый мозг _____ , сосудистые сплетения _____ .

23. Органы кровообращения: сердце: размеры _____ , масса _____ ,
эпикард и перикард _____ ,
консистенция сердечной мышцы _____ ,
кровенаполнение полостей сердца _____ ,
стустки крови _____ ,
проходимость предсердно-желудочковых отверстий _____ ,
толщина стенки желудочка левого _____ , правого _____ ,
толщина межжелудочковой перегородки _____ , эндокард _____ ,
миокард _____ ,
клапаны сердца _____ ,
венечные артерии _____ ,
аорта _____ , легочные артерии _____ ,
крупные вены _____ .

24. Органы дыхания: околоносовые пазухи _____,
гортань _____, слизистая оболочка трахеи и бронхов _____,
легкое: размеры _____, масса _____, форма _____,
воздушность _____,
плотность _____, плевральные листки _____,
ткань легкого на разрезе _____,
патологические образования _____,
водная проба _____,
состояние поперечных срезов: сосудов _____, бронхов _____;
прикорневые лимфатические узлы _____,
паратрахеальные лимфатические узлы _____.

25. Органы пищеварения: язык _____, небные миндалины _____,
пищевод _____,
желудок _____,
кишка: тонкая _____, толстая _____;
печень: размеры _____, масса _____, форма _____,
консистенция _____, окраска _____,
характер поверхности _____, вид на разрезе _____;
желчный пузырь _____, размеры _____,
консистенция желчи _____, стенки _____,
внепеченочные желчные протоки _____;
поджелудочная железа: размеры _____, масса _____,
консистенция _____, цвет _____,
рисунок ткани на разрезе _____,

_____.

26. Органы мочеполовой системы: почки: размеры _____, масса _____,
консистенция _____, характер поверхности _____,
вид на разрезе _____, толщина коркового вещества _____,
слизистая оболочка лоханок _____;
мочеточники _____, мочевой пузырь _____,
предстательная железа _____, матка _____,
маточные трубы _____,
влагалище _____, яичники _____.

27. Органы кроветворения: селезенка: размеры _____, масса _____,
консистенция _____, вид снаружи _____,

вид на разрезе _____, характер соскоба _____;
 лимфатические узлы: брыжейки _____, средостения _____,
 шеи _____; костный мозг _____.

28. Эндокринные железы: щитовидная железа: размеры _____, консистенция _____,
 вид: снаружи _____, на разрезе _____;
 надпочечники: форма _____, цвет на разрезе _____,
 рисунок ткани _____; гипофиз _____;
 парашитовидные железы _____

29. Костно-мышечная система: мышцы _____ ;
кости _____ ;
суставы _____ .

[illegible]

31. Для дополнительных исследований (указать каких) взяты: _____

32. Патолого-анатомический диагноз (предварительный) :
Основное заболевание:

код по МКБ-Х* _____

Осложнения основного заболевания: _____

Сопутствующие заболевания: _____

33. Описание результатов дополнительных исследований:

34. Патолого-анатомический диагноз

код по МКБ-Х* _____

Основное заболевание: _____

Осложнения основного заболевания: _____

Сопутствующие заболевания: _____

35. Сопоставление заключительного клинического диагноза и патолого-анатомического диагноза: _____

36. Дефекты оказания медицинской помощи: _____

37. Причина смерти: _____

38. Клинико-патолого-анатомический эпикриз: _____

39. Врач-патологоанатом: фамилия, инициалы _____ подпись _____

Заведующий патолого-анатомическим

отделением: фамилия, инициалы _____ подпись _____

40. Дата: "___" _____ 20___ года.

* [Международная статистическая классификация](#) болезней и проблем, связанных со здоровьем (X пересмотр).

Приложение N 3
к [приказу](#) Министерства здравоохранения РФ
от 6 июня 2013 г. N 354н

(полное наименование медицинской организации)

Код формы по [ОКУД](#) _____
Код учреждения по ОКПО _____

(адрес медицинской организации)

Утверждена [приказом](#) Минздрава России
от 6 июня 2013 г. N 354н

ПРОТОКОЛ
патолого-анатомического вскрытия
плода, мертворожденного или новорожденного N _____

" ____ " _____ 20 ____ г.

1. Наименование медицинской организации и отделения, в котором наблюдался и умер пациент(ка) _____
2. История родов, история развития новорожденного, история развития ребенка (подчеркнуть) N _____
3. Родился: плод - 1, мертворожденный - 2, новорожденный - 3
4. Фамилия, имя, отчество умершего новорожденного _____
5. Пол: мужской - 1, женский - 2, неизвестен - 3
6. Дата рождения: число _____ месяц _____ год _____, время _____
7. Дата смерти: число _____ месяц _____ год _____, время _____
8. Масса тела при рождении _____
9. Длина тела при рождении _____
10. Место смерти: республика, край, область _____ район _____
город _____ населенный пункт _____
улица _____ дом _____ квартира _____
11. Фамилия, имя, отчество матери _____
12. Место жительства (регистрации) матери: республика, край, область _____
район _____ город _____ населенный пункт _____
улица _____ дом _____ квартира _____
13. Местность: городская - 1, сельская - 2
14. Семейное положение: состояла в зарегистрированном браке - 1, не состояла в зарегистрированном браке - 2, неизвестно - 3
15. Образование: профессиональное: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее - 3, начальное - 4; общее: среднее (полное) - 5, основное - 6, начальное - 7; не имеет начального образования - 8, неизвестно - 9
16. Занятость: руководители и специалисты высшего уровня квалификации - 1, прочие специалисты - 2,

квалифицированные рабочие - 3, неквалифицированные рабочие - 4, занятые на военной службе - 5; пенсионеры - 6, студенты и учащиеся - 7, работавшие в личном подсобном хозяйстве - 8, безработные - 9, прочие - 10

17. Срок беременности _____ недель 18. Роды: одноплодные - 1, многоплодные - 2

19. Порядковый номер родов _____

20. Дата поступления в медицинскую организацию, в которой наблюдался и умер пациент(ка):

число _____ месяц _____ год _____, время _____

21. Фамилия, имя, отчество врача акушера-гинеколога (врача-неонатолога, акушерки) _____

22. Врач акушер-гинеколог (врач-неонатолог, акушерка, заведующий отделением) присутствовал(а) на патолого-анатомическом вскрытии (да - 1, нет - 2) _____

23. Дата проведения патолого-анатомического вскрытия: число _____ месяц _____ год _____

24. Основные клинические данные: _____

25. Заключительный клинический диагноз: _____ код по МКБ-X* _____

Основное заболевание: _____

Осложнения основного заболевания: _____

Сопутствующие заболевания: _____

ПАТОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКОЕ ВСКРЫТИЕ

26. Наружный осмотр тела:

рост _____ см., масса тела _____ кг.,
телосложение _____,
состояние питания _____,
состояние мышечной и костной систем _____,
кожный покров: головы _____,
шеи _____, груди _____,
туловища _____, конечностей _____;
трупные пятна и их расположение _____,
выраженность и распространенность трупного окоченения _____,
состояние естественных отверстий _____,
наружные половые органы _____,
операционные раны: длина разреза _____ см., характер операционной раны _____,
швы _____, выделения из раны _____,
следы инъекций и изменения в их зоне _____.

27. Брюшная полость:

расположение органов _____,
листки брюшины _____, сращения _____,
наличие свободной жидкости в брюшной полости _____;
внешний вид и размеры внутренних органов до вскрытия: диафрагма _____,
печень _____, селезенка _____,
большой сальник _____, желудок _____,
кишечник _____, мочевого пузыря _____,
червеобразный отросток _____.

28. Грудная полость:

расположение органов _____,
объем легкого _____, сращения и жидкость в плевральных полостях _____;
наружный осмотр сердца: форма _____, расположение _____;
вилочковая железа: расположение _____, величина _____.

29. Полость черепа:

мягкие покровы головы при отделении их от черепа _____,
кости черепа _____;
оболочки головного мозга: мягкая _____,
паутинная _____, твердая _____;
кровенаполнение сосудов _____;
головной мозг: объем _____, масса _____,
консистенция _____, вещество мозга _____,
желудочки _____, мозжечок _____,
продолговатый мозг _____, сосудистые сплетения _____.

30. Органы кровообращения: сердце: размеры _____, масса _____,
эпикард и перикард _____,
консистенция сердечной мышцы _____,
кровенаполнение полостей сердца _____,
сгустки крови _____,
проходимость предсердно-желудочковых отверстий _____,
толщина стенки желудочка левого _____, правого _____,
толщина межжелудочковой перегородки _____, эндокард _____,
миокард _____,
клапаны сердца _____,
венечные артерии _____,
аорта _____, легочные артерии _____,
крупные вены _____.

31. Органы дыхания: околоносовые пазухи _____,
гортань _____, слизистая оболочка трахеи и бронхов _____,
легкое: размеры _____, масса _____, форма _____,
воздушность _____,
плотность _____, плевральные листки _____,
ткань легкого на разрезе _____,
патологические образования _____.

водная проба _____,
состояние поперечных срезов: сосудов _____, бронхов _____;
прикорневые лимфатические узлы _____,
паратрахеальные лимфатические узлы _____.

32. Органы пищеварения: язык _____, небные миндалины _____,
пищевод _____,
желудок _____,
кишка: тонкая _____, толстая _____;
печень: размеры _____, масса _____, форма _____,
консистенция _____, окраска _____,
характер поверхности _____, вид на разрезе _____;
желчный пузырь _____, размеры _____,
консистенция желчи _____, стенки _____;
внепеченочные желчные протоки _____;
поджелудочная железа: размеры _____, масса _____,
консистенция _____, цвет _____,
рисунок ткани на разрезе _____

_____.

33. Органы мочеполовой системы: почки: размеры _____, масса _____,
консистенция _____, характер поверхности _____,
вид на разрезе _____, толщина коркового вещества _____,
слизистая оболочка лоханок _____;
мочеточники _____, мочевой пузырь _____,
предстательная железа _____, матка _____,
маточные трубы _____,
влагалище _____, яичники _____.

34. Органы кроветворения: селезенка: размеры _____, масса _____,
консистенция _____, вид снаружи _____,
вид на разрезе _____, характер соскоба _____;
лимфатические узлы: брыжейки _____, средостения _____,
шей _____; костный мозг _____.

35. Эндокринные железы: щитовидная железа: размеры _____, масса _____,
вид: снаружи _____, на разрезе _____;

надпочечники: форма _____, цвет на разрезе _____,
рисунок ткани _____; гипофиз _____;
паращитовидные железы _____.

36. Костно-мышечная система: мышцы _____;
кости _____;
суставы _____.

37. Плацента (при наличии): размеры _____, масса _____,

_____.

38. Плодные оболочки и пуповина: _____

_____.

39. Для гистологического исследования взяты: _____

_____.

40. Для дополнительных исследований (указать каких) взяты: _____

41. Патолого-анатомический диагноз (предварительный) :

код по МКБ-Х* _____

Основное заболевание: _____

Осложнения основного заболевания: _____

Сопутствующие заболевания: _____

[illegible]

Сопутствующие заболевания:

44. Сопоставление заключительного клинического диагноза и патолого-анатомического диагноза: _____

45. Дефекты оказания медицинской помощи: _____

46. Причина смерти: _____

47. Клинико-патолого-анатомический эпикриз: _____

48. Врач-патологоанатом: фамилия, инициалы _____ подпись _____
Заведующий патолого-анатомическим
отделением: фамилия, инициалы _____ подпись _____

49. Дата: " " 20 года.

(полное наименование медицинской организации)

(адрес медицинской организации)

Приложение N 4
к приказу Министерства здравоохранения РФ
от 6 июня 2013 г. N 354н

Медицинская документация
Форма N 015/у
Утверждена **приказом** Минздрава
России
от 6 июня 2013 г. N 354н

ЖУРНАЛ
регистрации поступления и выдачи тел умерших

Начат " " 20 г. окончен " " 20 г.

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--

